

TEMA 2.5 • GINECOLOGÍA

Patología Benigna del Útero

PERFIL EUNACOM 2.01.1.068

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patología Benigna del Útero

Comparación Rápida

TABLA 2.5.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS			
	MIOMA	ADENOMIOSIS	PÓLIPO ENDOMETRIAL
Tejido de origen	Miometrio (músculo)	Endometrio → miometrio	Endometrio
Útero	Nodular, aumentado	Aumentado, liso	Normal o aumentado
Síntoma principal	Hipermenorrea (o asintomático)	Dismenorrea + hipermenorrea	Hipermenorrea
Diagnóstico	ETV (masa sólida hipoeoica)	ETV (miometrio heterogéneo)	ETV (pólipo)
Confirmación histológica	Post-histerectomía	Post-histerectomía	Post-polipectomía

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Clave diferencial: - Útero nodular + hipermenorrea = **Mioma** - Útero liso aumentado + hipermenorrea + **dismenorrea** = **Adenomiosis** - Si hay metrorragia (fuera del ciclo) → pensar en cáncer, no en estas patologías benignas

1. Miomatosis Uterina

Causa: Neoplasia benigna del miometrio. Estrógeno-dependiente (desaparece con la menopausia).

- **Clínica:**
- Mayoría **asintomáticos**
- **Hipermenorrea** (sangrado uterino abundante) — síntoma más frecuente
- Abortos / parto prematuro (submucoso)
- Útero palpable nodular aumentado (subseroso)

Clasificación

TABLA 2.5.2: TIPO VS UBICACIÓN		
TIPO	UBICACIÓN	CARACTERÍSTICAS
Intramural	Dentro del miometrio	Más frecuente; habitualmente asintomático
Submucoso	Hacia el endometrio	Más sintomático: hipermenorrea, abortos, parto prematuro
Subseroso	Superficie externa	Se manifiesta como tumor pélvico palpable

Diagnóstico: ETV → masa sólida hipoeoica (puede ser hiperecoica si está calcificada).

Tratamiento

TABLA 2.5.3: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO
Asintomático	Observación (sin importar tamaño)
Sintomático + paridad cumplida	Histerectomía
Sintomático + deseos de paridad	Miomectomía (histeroscopia o laparoscopia) — preserva útero
Perimenopausia + síntomas	Observación expectante (menopausia resolverá) ± cirugía
Alto riesgo quirúrgico o miomas muy grandes	Agonistas de GnRH (reducen tamaño previo a cirugía)

NOTA CLÍNICA

Agonistas de GnRH: La GnRH fisiológica es pulsátil. Al dar análogos de forma continua, se bloquea el eje hipotálamo-hipófisis-ovario → caída de estrógenos → reducción del mioma (tratamiento puente, no definitivo).

2. Adenomiosis

Definición: Endometrio ectópico dentro del miometrio. Idiopática.

- **Clínica:**
- **Dismenorrea** (dolor menstrual intenso)
- **Hipermenorrea**
- Útero aumentado de tamaño, **liso** (no nodular)

Diagnóstico: ETV → miometrio heterogéneo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Miometrio heterogéneo en ETV puede ser adenomiosis o cáncer de endometrio. Diferencia clave: adenomiosis → hipermenorrea; cáncer → **metrorragia** (sangrado fuera del ciclo). La confirmación definitiva es histológica (post-histerectomía).

Tratamiento

TABLA 2.5.4: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO
Paridad cumplida	Histerectomía (con biopsia confirmatoria)
Deseos de paridad	Observación + embarazo → histerectomía posterior
Síntomas severos + deseos de paridad	Agonistas de GnRH (reducen endometrio)

3. Pólipos Endometriales

Causa: Neoplasia benigna del endometrio.

Clínica: Hipermenorrea o sangrado uterino anormal.

Diagnóstico: ETV → imagen de pólipo endometrial.

Tratamiento: **Polipectomía** vía histeroscopia + biopsia del espécimen.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

A diferencia de los miomas, los pólipos **NO** requieren histerectomía. La polipectomía histeroscópica es suficiente y permite el diagnóstico histológico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Respecto a Patología Benigna del Útero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Patología Benigna del Útero. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Comparación Rápida
- 1. Miomatosis Uterina
- Clasificación
- Tratamiento
- 2. Adenomiosis
- 3. Pólipos Endometriales
- | Normal o aumentado | | Síntoma principal | Hipermenorrea (o asintomático) |

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍA BENIGNA DEL ÚTERO)**PREGUNTA 1**

Respecto a Patología Benigna del Útero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Patología Benigna del Útero se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Patología Benigna del Útero debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Patología Benigna del Útero requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Patología Benigna del Útero es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Patología Benigna del Útero no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Patología Benigna del Útero?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Patología Benigna del Útero. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PATOLOGÍA BENIGNA DEL ÚTERO

:::note Agonistas de GnRH: La GnRH fisiológica es pulsátil. Al dar análogos de forma continua, se bloquea el eje hipotálamo-hipófisis-ovario → caída de estrógenos → reducción del mioma (tratamiento puente, no definitivo). :::
:::warning Miometrio heterogéneo en ETV puede ser adenomiosis o cáncer de endometrio. Diferencia clave: adenomiosis → hipermenorrea; cáncer → metrorragia (sangrado fuera del ciclo). La confirmación definitiva es histológica (post-histerectomía). :::
:::tip A diferencia de los miomas, los pólipos NO requieren histerectomía. La poliopectomía histeroscópica es suficiente y permite el diagnóstico histológico. :::